

26. PRÁCTICA : LOS PULMONES

DURACIÓN : 05:35

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo se centra en el enfoque biodinámico de los pulmones, haciendo hincapié en cómo el movimiento de balanceo de los pulmones y la búsqueda del punto de fulcro embrionario son esenciales para restaurar su función primaria. Los participantes aprenderán a observar la dinámica entre los pulmones, la pleura y el tejido circundante, incluyendo cómo las emociones, como la tristeza, pueden alojarse en ellos e influir en la respiración. También se abordan técnicas para iniciar un diálogo tisular y liberar los espacios pleurales congestionados de exudados, destacando la importancia de la reorganización estructural y emocional de los pulmones para mejorar la salud respiratoria.

PRÁCTICA DE LOS PULMONES

La **mano posterior** está ligeramente más baja que la **mano anterior**, que está ligeramente más alta. Esto se debe al movimiento de **balanceo** de los pulmones sobre su eje. Este movimiento es esencial para situarse en el **campo embrionario** de los pulmones, donde se busca el **punto de fulcro embrionario**. Este punto representa un campo de aspiración, permitiendo repotencializarse en la función primaria de los pulmones, es decir, estar listo para **tomar el aliento de vida**.

Durante los nueve meses de desarrollo embrionario, los pulmones se preparan para este primer movimiento. Fabrican **líquido amniótico**, una función crucial ya que el embrión lo necesita para su supervivencia. Este líquido proviene en parte de la orina de los riñones. Más tarde, se producirá una **proteína específica** llamada **surfactante**, que permitirá la apertura de los pulmones en el momento del nacimiento.

Al principio, la presión ejercida es suave. Se trata de encontrar progresivamente un espacio donde el pulmón pueda organizarse y recuperar su libertad. Entre la **pleura visceral** y la **pleura parietal**, existe un encuentro entre la tráquea, el bronquio y el tejido bronquial aéreo, que contiene aire y un volumen residual, así como un espacio líquido.

Es importante señalar que este tejido puede albergar emociones, como una **tristeza** interiorizada. Por ejemplo, un niño que llora en sus pulmones o que sufre de bronquitis puede expresar una tristeza que no sabe verbalizar. Trabajando suavemente sobre este tejido, es posible

iniciar un diálogo y un intercambio **oxidativo tisular**.

A través de la **gran cisura posterior**, se puede acceder a espacios donde se esconden emociones. Es esencial dejar que el cuerpo trabaje y concentrarse en el eje de reorganización. Los **recesos costopleuropulmonares** son sacos de acumulación de exudados, donde se depositan los desechos de los pulmones. Estas zonas, a menudo menos móviles, necesitan ser dinamizadas y liberadas.

También es crucial liberar los pulmones en relación con sus puntos de anclaje, especialmente los **ligamentos suspensorios de la cúpula pleural**. Los recesos, como los **recesos costodiafragmáticos** y el **receso frenomediastínico**, desempeñan un papel importante en la libertad del mediastino y del corazón.

La producción de líquido amniótico comienza en la **quinta semana** de embarazo y se desarrolla hasta la **semana 38**, con la aparición del surfactante alrededor de la **semana 25**. Las patologías pulmonares, como la bronquitis o la bronquiolitis, pueden ser manifestaciones que buscan resolver problemas no expresados durante la etapa embrionaria, manifestándose en forma de **líquido**. Se puede decir que se "llora en los pulmones".

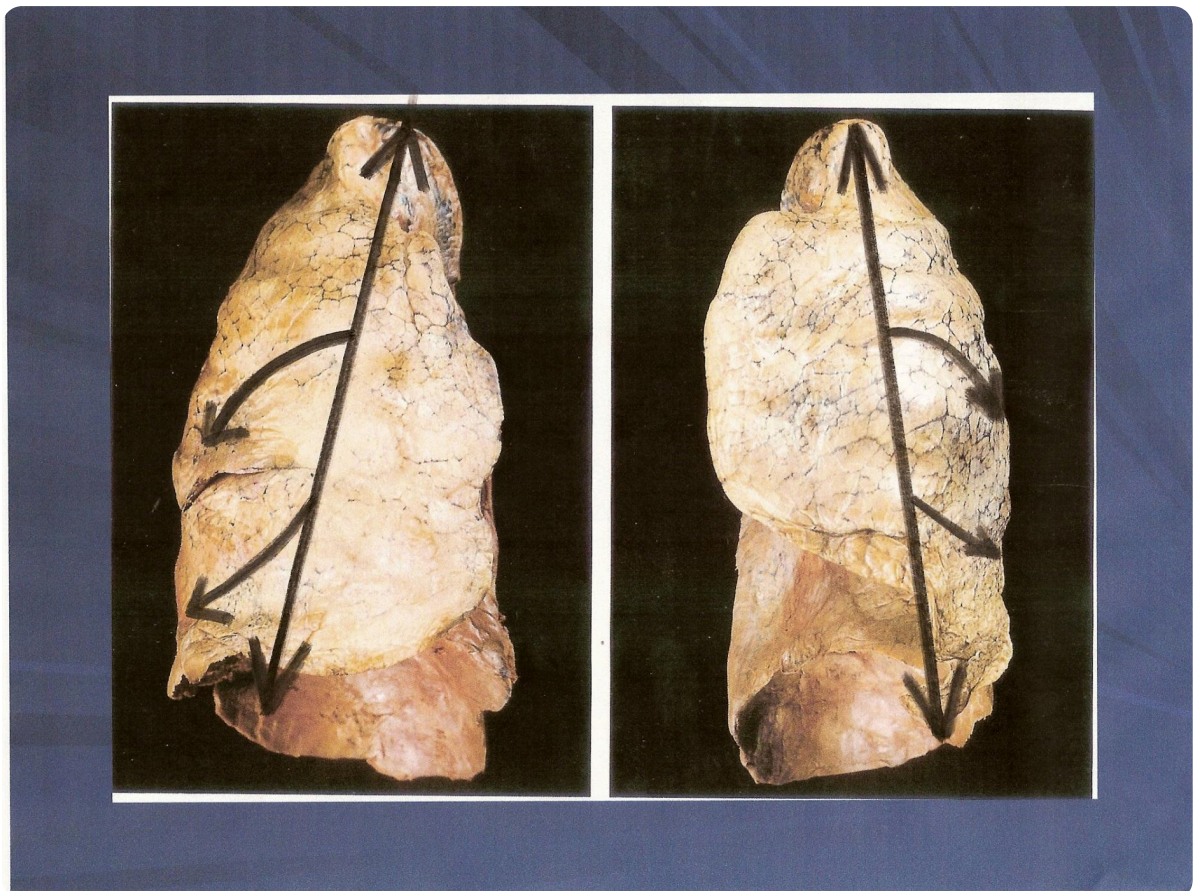


FIG. — Lóbulo superior oblicuo

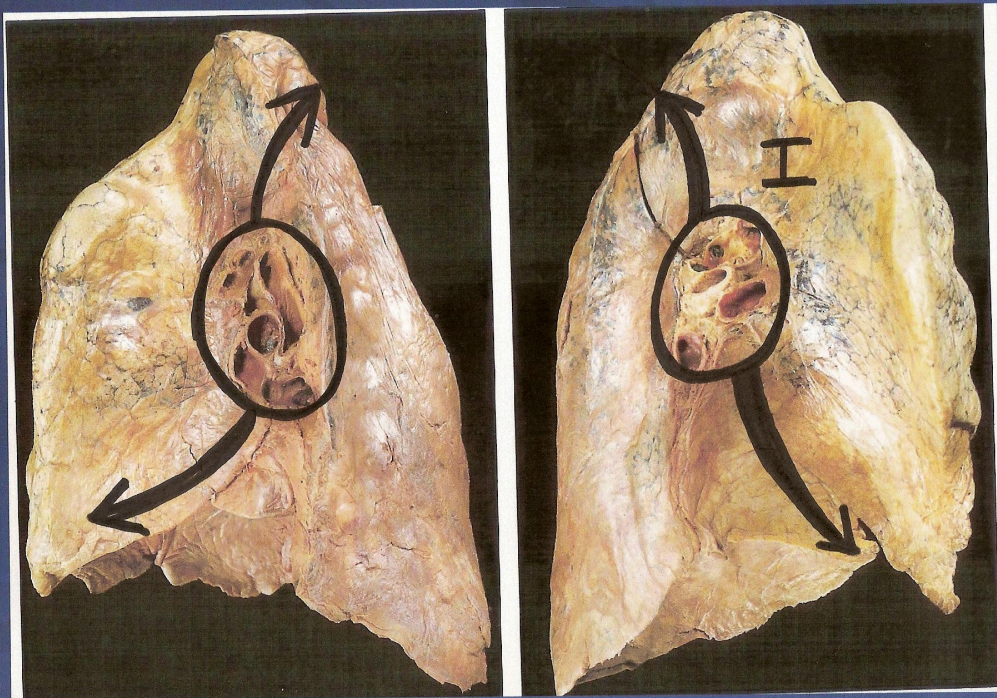


FIG. — *Enfermedad pulmonar quística*